Клинические рекомендации

Рак полости носа и придаточных пазух

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C30** — Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха **C31** — Злокачественное новообразование придаточных пазух
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/3_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Клиническая картина 4

2.4 Классификация TNM (8-е издание, 2017) 4

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы, анамнез и осмотр 5

3.3 Биопсия слизистой оболочки полости носа 5

3.4 КТ, МРТ, УЗИ, ПЭТ-КТ 5

3.5 Обследование перед операцией 6

3.6 Патологоанатомическое исследование операционного материала 6

4. Лечение 6

4.1 Рак полости носа и клеток решётчатого лабиринта 6

4.2 Рак верхнечелюстной пазухи (кроме меланомы, саркомы, лимфомы) 7

4.3 Лучевая терапия 8

4.4 Лекарственное лечение 8

4.5 Хирургическое лечение 10

5. Диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации и выписке 10
5.1 Диспансерное наблюдение 10
5.2 Организация медицинской помощи 11
5.3 Показания к госпитализации 11
5.4 Показания к выписке 11
6. Источник и актуальность 11
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 11

1. Основные положения

- Рак полости носа и придаточных пазух представляет собой злокачественную опухоль из элементов слизистой оболочки полости носа и пазух.
- Поводом заподозрить рак является заложенность носа, не поддающаяся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**. Первыми проявлениями бывают также выделения из носа, боль, экзофтальм при распространении в орбиту.
- Ранний рак решётчатого лабиринта в большинстве случаев выявляют при гистологическом исследовании материала после операций по поводу предполагаемых неопухолевых процессов (полипозный этмоидит, полипы полости носа).
- Диагноз верифицируется биопсией слизистой оболочки полости носа. Распространённость оценивают по КТ лицевого черепа и шеи с контрастированием и (или) МРТ, УЗИ лимфоузлов шеи.
- При подозрении на рак пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи, консультация проводится **не позднее 5 рабочих дней**.
- Основным методом лечения при Т1–Т4а является хирургическое вмешательство с последующей лучевой (ЛТ) или химиолучевой терапией (ХЛТ) по показаниям. Тактику определяет онкологический консилиум.
- Плановая госпитализация показана для специализированного противоопухолевого лечения, а экстренная при осложнениях заболевания или лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Верхняя стенка полости носа представлена сетевидной (решётчатой) пластинкой, передней стенкой основной пазухи, передними клетками решётчатого лабиринта; внутренняя — перегородкой носа; наружная — медиальной стенкой верхнечелюстной пазухи; задняя — хоанами; передняя — грушевидным отверстием.

Радикальная операция (R0) — удаление поражённого органа в пределах здоровых тканей вместе с зонами регионарного метастазирования без остаточных проявлений опухолевого процесса.

2.2 Этиология и эпидемиология

Этиологические факторы

1. хронические воспалительные заболевания: хронические синуситы, вазомоторный ринит, бронхиальная астма, инвертированная папиллома;
2. неблагоприятные факторы внешней среды;
3. канцерогены физической и химической природы, особенно на вредном производстве.

Злокачественные опухоли полости носа и пазух составляют 1,4% всех злокачественных опухолей; в 2021 г. в России — 1012 новых случаев.

2.3 Клиническая картина

Первые проявления

1. заложенность носа;
2. выделения из полости носа;
3. болевой синдром;
4. экзофтальм при распространении в орбиту.

В 70% случаев опухоли эпителиальные: плоскоклеточный рак составляет 80%, аденокарцинома 6%, эстезионейробластома 10%, редко встречается меланома.

2.4 Классификация TNM (8-е издание, 2017)

Символ T: верхнечелюстная пазуха

T	Верхнечелюстная пазуха
T1	ограничена слизистой оболочкой без эрозии или деструкции кости
T2	эрозия или разрушение кости, включая твёрдое нёбо и (или) средний носовой ход, без распространения на заднюю стенку пазухи и крыловидные отростки
T3	задняя стенка пазухи, подкожная клетчатка, дно или медиальная стенка орбиты, крыловидная ямка, решётчатые клетки
T4a	передний край орбиты, кожа щеки, крыловидные отростки, подвисочная ямка, сетевидная пластинка, основная или лобная пазуха
T4b	купол орбиты, твёрдая мозговая оболочка, мозг, средняя черепная ямка, черепные нервы (кроме верхнечелюстной ветви тройничного), носоглотка, скат

Символ T: полость носа и решётчатый лабиринт

T	Полость носа, клетки решётчатого лабиринта
T1	одна сторона полости носа или решётчатых клеток, с эрозией кости или без
T2	две стороны полости носа и прилежащие участки в пределах полости носа и решётчатых клеток
T3	медиальная стенка или дно орбиты, верхнечелюстная пазуха, нёбо, решётчатые клетки
T4a	передние структуры орбиты, кожа носа или щёк, минимально передняя черепная ямка, крыловидные отростки, основная или лобная пазуха
T4b	купол орбиты, твёрдая мозговая оболочка, головной мозг, средняя черепная ямка, черепные нервы (кроме верхнечелюстной ветви тройничного), носоглотка, скат

Символ N (регионарные лимфатические узлы)

1. **N1**: один ипсилатеральный лимфоузел до 3 см без экстранодального распространения (ENE−);
2. **N2**: до 3 см с ENE+ или 3–6 см ENE−; несколько ипсилатеральных или контралатеральные до 6 см ENE−;
3. **N3**: более 6 см ENE− или любой с ENE+, кроме N2a.

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
I	T1N0
II	T2N0

Стадия	TNM
III	T3N0 или T1–T3N1
IVA	T4a N0–N2; T1–T3 N2
IVB	любая T N3; T4b любая N
IVC	M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: заложенность носа, не поддающаяся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**;
2. осмотра и пальпации образования, прилежащих тканей и регионарных лимфоузлов;
3. цитологии соскоба, мазков, пунктата опухоли и лимфоузлов;
4. патологоанатомического исследования биопсийного материала;
5. инструментального обследования: УЗИ шеи, КТ лицевого черепа и шеи с контрастом и (или) МРТ, ПЭТ-КТ, фиброларингоскопия по показаниям.

3.2 Жалобы, анамнез и осмотр

Тщательный сбор жалоб и анамнеза необходим каждому пациенту для выбора тактики лечения.

Физикальное обследование включает осмотр и бимануальную пальпацию очага и регионарных лимфоузлов, оценку нутритивного статуса.

3.3 Биопсия слизистой оболочки полости носа

Диагноз верифицируется биопсией слизистой оболочки полости носа. При верифицированной опухоли определяют гистологический тип и степень дифференцировки.

При сомнительном результате обязательна повторная биопсия в достаточном объёме с иммуногистохимией; при повторно отрицательном результате биопсию повторяют при убедительных клинических и (или) рентгенологических признаках злокачественной опухоли.

3.4 КТ, МРТ, УЗИ, ПЭТ-КТ

Распространённость опухоли оценивают по КТ лицевого черепа и шеи с болюсным контрастированием и (или) МРТ лицевого черепа и шеи с контрастом.

Стадирование

1. УЗИ лимфоузлов шеи и тонкоигольная биопсия изменённых узлов под УЗИ или КТ;
2. УЗИ органов брюшной полости;
3. КТ органов грудной полости (при невозможности — рентгенография лёгких);
4. при T3–T4 или N1 и более — ПЭТ-КТ или КТ грудной и брюшной полостей с контрастом;
5. фиброларингоскопия и ЭГДС по показаниям.

Через **2–3 месяца** после ЛТ или ХЛТ эффект оценивают по ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозой (ФДГ) или МРТ с контрастом.

При симптомах рецидива или установленном рецидиве показана ПЭТ-КТ; если ПЭТ-КТ или КТ грудной и брюшной полостей с контрастом недоступны, выполняют рентгенографию органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости.

3.5 Обследование перед операцией

Для оценки функционального статуса по показаниям выполняют

1. эхокардиографию;
2. холтеровское мониторирование сердечного ритма;
3. исследование функции внешнего дыхания;
4. ультразвуковую допплерографию артерий и вен нижних конечностей;
5. консультации кардиолога, эндокринолога, невролога.

3.6 Патологоанатомическое исследование операционного материала

В заключении по операционному материалу отражают

1. размер, глубину инвазии, гистологическое строение и дифференцировку;
2. лимфоваскулярную и периневральную инвазию;
3. pT, pN с числом исследованных и поражённых узлов и экстранодальным распространением;
4. состояние краёв резекции.

---

4. Лечение

4.1 Рак полости носа и клеток решётчатого лабиринта

Лечение рака полости носа и решётчатого лабиринта

Стадия	Тактика лечения
T1–T2, первично выявленный	операция, после неё ЛТ; наблюдение только при T1 с благоприятными признаками (чистые края, нет прилежания к сетевидной пластинке и медиальной стенке орбиты, высокая дифференцировка)
T3–T4a	операция на первом этапе, или ЛТ/ХЛТ, или индукционная химиотерапия (ХТ) с операцией или ХЛТ; после операции ЛТ или ХЛТ при опухоли в краях резекции и (или) внутричерепном распространении
T4b, отказ от операции или противопоказания к ней	по шкале ECOG: 0–1 балл: ХЛТ или индукционная ХТ с ЛТ; 2 балла: ЛТ ± ХТ; 3 балла: паллиативная ЛТ, монохимиотерапия или паллиативная помощь

Если диагноз установлен после неполного удаления (полипэктомия) и сохраняется остаточная опухоль, рекомендованы хирургическое удаление, ЛТ или конкурентная ХЛТ.

После операции ЛТ или одновременная ХЛТ показаны при неблагоприятных прогностических факторах

1. опухолевые клетки в краях резекции;
2. прилежание опухоли к сетевидной пластинке, медиальной стенке орбиты;
3. интракраниальное или внутриорбитальное распространение;
4. неблагоприятная гистология: низкодифференцированные опухоли, аденокистозный рак;
5. периневральная или лимфатическая инвазия.

Нерадикальная первая операция фактически является расширенной биопсией, и дальнейшее лечение проводят как при впервые установленном диагнозе. Метастазы в лимфоузлы шеи при раке полости носа и решётчатого лабиринта крайне редки; при их выявлении выполняют шейную лимфодиссекцию.

Если до операции выполнялись КТ или МРТ, нерадикальная операция может быть дополнена одной радикальной ЛТ только при формальной стадии T1–T2, без распространения на основание черепа.

Если после нерадикального удаления остаточная опухоль клинически и по данным обследования не определяется, рекомендованы ЛТ или операция с последующей ЛТ.

Наблюдение без лечения допустимо только при T1 и благоприятных признаках

1. резекция R0;
2. центральное расположение опухоли;
3. высокая дифференцировка;
4. отсутствие периневральной и лимфатической инвазии.

При синоназальной недифференцированной карциноме, низкодифференцированной эстезионейробластоме, синоназальном нейроэндокринном раке в план включают системную химиотерапию.

4.2 Рак верхнечелюстной пазухи (кроме меланомы, саркомы, лимфомы)

Лечение рака верхнечелюстной пазухи

Стадия	Тактика лечения
T1–T2 N0 (кроме аденокистозного рака)	радикальная операция и наблюдение; при периневральной, сосудистой, лимфатической инвазии ЛТ или ХЛТ; при положительных краях резекция и ЛТ, при повторной нерадикальной операции одновременная ХЛТ
T1–T2 N0, аденокистозный рак	радикальная операция и ЛТ; наблюдение возможно при R0 и отсутствии периневральной инвазии
T3–T4a N0	радикальная операция, затем ЛТ; при опухоли в краях резекции ХЛТ
T1–T4a N+	удаление опухоли и расширенная шейная лимфаденэктомия, затем ЛТ; при опухоли в краях или экстракапсулярном распространении ХЛТ
T4b, отказ от операции	по шкале ECOG: 0–1 балл: ХЛТ или индукционная ХТ с ЛТ; 2 балла: ЛТ ± ХТ; 3 балла: паллиативная ЛТ, монохимиотерапия или паллиативная помощь

1. **рецидив без предшествующей ЛТ**: операция, ХЛТ или индукционная ХТ с ХЛТ;
2. **рецидив после ЛТ**: операция с обсуждением повторной ЛТ, при невозможности операции повторная ЛТ и противорецидивная ХТ;
3. **рецидив с отдалёнными метастазами**: по шкале ECOG, как при T4b.

Если при плановом гистологическом исследовании после операции выявлены

1. прорастание опухолью капсулы лимфоузла, периневральная инвазия, опухолевые эмболы в сосудах: показана одновременная ХЛТ;
2. положительные края резекции: рассматривают повторную операцию или ЛТ.

Шкала ECOG

Балл	Общее состояние
0	полностью активен, способен выполнять всё, как до заболевания (90–100 баллов по шкале Карновского)
1	выполняет сидячую работу, например лёгкую домашнюю или канцелярскую (70–80 баллов по шкале Карновского)
2	лечится амбулаторно, способен к самообслуживанию, но не может выполнять работу; более 50% времени бодрствования активен, в вертикальном положении (50–60 баллов по шкале Карновского)
3	способен лишь к ограниченному самообслуживанию, проводит в кресле или постели более 50% времени бодрствования (30–40 баллов по шкале Карновского)

Балл	Общее состояние
4	инвалид, совершенно не способен к самообслуживанию, прикован к креслу или постели (10–20 баллов по шкале Карновского)

4.3 Лучевая терапия

До лечения всех пациентов оценивает радиотерапевт, предпочтительно специализирующийся на опухолях головы и шеи: адекватность верификации, стадирования и визуализации, отсутствие синхронной первичной опухоли, функциональный статус и возможность ЛТ или ХЛТ.

1. **самостоятельная ЛТ**: на опухоль и метастазы в лимфоузлах 70 Гр (1,8–2,0 Гр за фракцию) **7 недель**, на неизменённые лимфоузлы 50 Гр;
2. **послеоперационная ЛТ**: на ложе опухоли и поражённые узлы 60–66 Гр, на неизменённые узлы 50 Гр; интервал после операции **до 6 недель**, **не более 3 месяцев**.

Послеоперационная ХЛТ

1. ЛТ на первичный очаг и клинически определяемые метастазы 66–70 Гр (2,0 Гр за фракцию) за **6–7 недель**, на локорегионарную область 46–54 Гр;
2. цисплатин 100 мг/м^2 на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни ЛТ или еженедельно #40 мг/м^2, суммарно 300 мг/м^2 за курс ЛТ;
3. при противопоказаниях к препаратам платины: цетуксимаб.

Противопоказания к препаратам платины

1. хроническая почечная недостаточность, СКФ менее 50–60 мл/мин;
2. возраст **старше 65 лет**;
3. выраженная почечная, сердечно-сосудистая, неврологическая, печёночная патология;
4. ослабленное состояние (ECOG более 1).

Паллиативную ЛТ применяют для облегчения симптомов при невозможности радикального лечения: 50 Гр по 2,5 Гр или 30 Гр по 3 Гр.

4.4 Лекарственное лечение

Индукционная ХТ с последующей одновременной ХЛТ: доцетаксел + цисплатин + фторурацил, 2–3 курса с интервалом 3 недели.

Индукционная ХТ при нейроэндокринной опухоли и низкодифференцированной эстезионейробластоме

1. карбоплатин AUC 5–6 + #этопозид 100 мг/м^2 в 1–3-й дни;
2. цисплатин 75 мг/м^2 + #этопозид 100 мг/м^2 в 1–3-й дни;
3. #циклофосфамид + доксорубицин + #винкристин;
4. цисплатин 50 мг/м^2 + доксорубицин 50 мг/м^2 + #циклофосфамид 500 мг/м^2 в 1-й день каждые 3 недели.

Одновременная ХЛТ

1. ЛТ на первичный очаг и клинически определяемые метастазы 70 Гр (2,0 Гр за фракцию) за **6–7 недель**, на неизменённые лимфоузлы 44–60 Гр;
2. цисплатин (предпочтительно) 100 мг/м^2 на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни ЛТ, суммарно 300 мг/м^2;
3. или еженедельно карбоплатин AUC 1,5–2,0;
4. или цетуксимаб 400 мг/м^2 за неделю до начала ЛТ, затем 250 мг/м^2 еженедельно во время ЛТ.

При рецидивных, первично неоперабельных опухолях или метастатическом процессе, если одновременная ХЛТ невозможна, рекомендуется поли- или монохимиотерапия с учётом общего состояния и целей лечения; число курсов определяется переносимостью и эффективностью.

Противорецидивные режимы с цисплатином и цетуксимабом

1. PF + цетуксимаб: цисплатин 75–100 мг/м² в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза), далее 250 мг/м² еженедельно; после 6 циклов при отсутствии прогрессирования поддерживающая терапия цетуксимабом 250 мг/м² еженедельно;
2. DC + цетуксимаб: #доцетаксел 75 мг/м² + цисплатин 75 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м², далее 250 мг/м² еженедельно; после 4 циклов поддерживающая терапия цетуксимабом 500 мг/м² 1 раз в 2 недели;
3. цисплатин + цетуксимаб: цисплатин 75–100 мг/м² 1 раз в 3 недели (не более 6–8 введений) + цетуксимаб 400 мг/м², далее 250 мг/м² еженедельно до прогрессирования или непереносимой токсичности;

Противорецидивные режимы с паклитакселом, карбоплатином и цетуксимабом

1. паклитаксел + карбоплатин + цетуксимаб: #паклитаксел 100 мг/м² + карбоплатин AUC 2,5 в 1-й и 8-й дни + цетуксимаб 400 мг/м², далее 250 мг/м² еженедельно, цикл 21 день; после 6 циклов поддерживающая терапия цетуксимабом;
2. еженедельно: #паклитаксел 80 мг/м² + карбоплатин AUC 2,0 + цетуксимаб 400 мг/м², далее 250 мг/м², затем поддерживающая терапия цетуксимабом;

Противорецидивные режимы без цетуксимаба

1. PF: цисплатин 75–100 мг/м² в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели;
2. карбоплатин AUC 5 в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м² 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели, 6 циклов, возможно до 8;
3. #паклитаксел 175 мг/м² + карбоплатин AUC 5–6 в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов, возможно до 8;
4. #паклитаксел 60–80 мг/м² + карбоплатин AUC 2 еженедельно, не более 18 недель;
5. DC: #доцетаксел 75 мг/м² + цисплатин 75 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов, возможно до 8;

Иммунотерапия

1. ниволумаб: 3 мг/кг или 240 мг 1 раз в 2 недели, или 480 мг 1 раз в 4 недели, не более 2 лет (во 2-й и последующих линиях при платинорезистентных опухолях);
2. пембролизумаб: 200 мг 1 раз в 3 недели или 400 мг 1 раз в 6 недель, не более 2 лет;
3. PF + пембролизумаб: пембролизумаб 200 мг + карбоплатин AUC 5 или цисплатин 100 мг/м² + фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни 1 раз в 3 недели (6 циклов), далее пембролизумаб, всего до 35 введений.

Монотерапия при ECOG более 2 баллов

1. цисплатин 60–70 мг/м² 1 раз в 3 недели;
2. карбоплатин AUC 5–6 1 раз в 3 недели или AUC 2 еженедельно;
3. #паклитаксел 175 мг/м² 1 раз в 3 недели или 80 мг/м² еженедельно;
4. #доцетаксел 70–75 мг/м² 1 раз в 3 недели;
5. #капецитабин 2000 мг/м² внутрь в 2 приёма в 1–14-й дни, перерыв 1 неделя, или 2000 мг/сут в метрономном режиме;
6. #метотрексат 40 мг/м² еженедельно;
7. цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день 1-го курса, далее 250 мг/м² еженедельно.

4.5 Хирургическое лечение

До лечения всех пациентов оценивают хирург и онколог, специализирующиеся на опухолях головы и шеи. Первичную опухоль удаляют единым блоком с чистыми краями: чистым считается край **5 мм и более** от инвазивного края опухоли. При прилежании опухоли к нерву выполняют резекцию нерва со срочным гистологическим исследованием краёв.

Поражение структур, связанное с плохим прогнозом

1. значительное поражение крылонёбной ямки;
2. тяжёлый тризм из-за инфильтрации крыловидных мышц;
3. распространение на основание черепа;
4. охват сонной артерии на **270° и более**;
5. распространение на кожу, средостение, предпозвоночную фасцию или шейные позвонки.

Адекватным считается удаление с расстоянием от края резекции до видимой опухоли не менее 2 см или с отрицательным краем замороженного среза. Срочное исследование краёв проводят, если свободная зона менее 2 см, граница опухоли нечёткая или есть подозрение на резидуальную опухоль. Близким считается край менее 5 мм.

При угрозе кровотечения из опухоли оценивают риск и выполняют ангиографию с суперселективной эмболизацией сосудов опухоли.

Реабилитацию проводят по общим принципам реабилитации после операций и химиотерапии.

---

5. Диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации и выписке

5.1 Диспансерное наблюдение

Частота осмотров после лечения

1. 1–2-й год: **каждые 3–6 месяцев**;
2. 3–5-й год: **1 раз в 6–12 месяцев**;
3. после 5 лет: ежегодно или при жалобах.

Обследование по разделу 2.4.3 КР

1. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон: **каждые 3 месяца** в 1-й год, каждые 3–6 месяцев во 2-й, ежегодно в 3–5-й;
2. КТ или МРТ лицевого черепа и шеи: каждые 3 месяца в 1-й год, 3–6 месяцев во 2-й, далее по показаниям;
3. КТ органов грудной полости каждые 12 месяцев;
4. фиброларингоскопия и ЭГДС при жалобах; при подозрении на рецидив ПЭТ-КТ.

УЗИ органов брюшной полости: **каждые 3 месяца** в 1-й год, каждые 3–6 месяцев во 2-й, в 3–5-й год 1 раз в 6–12 месяцев.

Объём обследования по разделу 5 КР

1. анамнез и физикальное обследование;
2. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон, органов брюшной полости и малого таза **каждые 3–6 месяцев** в зависимости от риска прогрессирования;
3. рентгенография органов грудной клетки **каждые 12 месяцев**.

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой специалист направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи; консультация проводится **не позднее 5 рабочих дней**, патологоанатомическое исследование **не более 15 рабочих дней**. Тактику лечения определяет онкологический консилиум.

5.3 Показания к госпитализации

Экстренная или неотложная госпитализация

1. осложнения онкологического заболевания, требующие специализированной помощи в экстренной или неотложной форме;
2. осложнения лечения (операции, ЛТ, лекарственной терапии).

Плановая госпитализация

1. сложные интервенционные диагностические вмешательства, требующие наблюдения в круглосуточном или дневном стационаре;
2. специализированное противоопухолевое лечение (операция, ЛТ, лекарственная терапия), требующее наблюдения в круглосуточном или дневном стационаре.

5.4 Показания к выписке

1. завершение курса или этапа лечения при отсутствии осложнений, требующих коррекции в стационаре;
2. отказ пациента или законного представителя от лечения в стационаре при отсутствии осложнений, требующих коррекции в стационаре;
3. несоблюдение предписаний или правил внутреннего распорядка, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих;
4. необходимость перевода в другую медицинскую организацию по профилю.

Факторы прогноза

1. размер и распространённость опухоли, дифференцировка;
2. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
3. метастазы в лимфоузлах шеи (вдвое снижают выживаемость), экстранодальное распространение;
4. индекс Ki-67, статус краёв резекции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак полости носа и придаточных пазух»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 24.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	3_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Периодичность наблюдения в разделах 2.4.3 и 5 различается: в 2.4.3 УЗИ шеи — каждые 3 месяца в 1-й год и ежегодно в 3–5-й, в разделе 5 — каждые 3–6 месяцев; осмотры в 1–2-й год указаны как

«каждые 36 месяца» (вероятно, 3–6).